

Болезнь Пейрони

Информация для пациента · Рубцовая ткань, вызывающая искривление полового члена — и способы лечения

WARWIKI

Болезнь Пейрони — это состояние, при котором в стенке полового члена формируется участок рубцовой ткани (**бляшка**), вызывающий его **искривление, сужение, вдавливание или укорочение**, иногда с болью при эрекции. Это может затруднять половой акт. Заболевание встречается часто, **не является раком** и хорошо поддаётся лечению — выбор метода зависит от стадии.

Об этом состоянии

Болезнь Пейрони, как правило, проходит две фазы:

- **Активная (острая) фаза** — искривление нарастает, может быть боль; обычно продолжается 6–18 месяцев.
- **Стабильная фаза** — искривление и бляшка перестают меняться, боль обычно стихает.

Выбор лечения зависит от текущей фазы, поэтому врач спросит, как менялось состояние со временем.

Причины

Считается, что заболевание возникает после небольшой травмы или перегиба полового члена во время полового акта, когда заживление происходит с образованием аномального рубца. Чаще встречается с возрастом, при сахарном диабете, после операции на простате и у мужчин с **контрактурой Дюпюитрена** (схожее поражение ладони).

ТЕРМИНЫ

Болезнь Пейрони

Рубцовая ткань в половом члене, вызывающая искривление или деформацию.

Бляшка

Участок рубцовой ткани, ответственный за изгиб.

Активная / стабильная фаза

Изменяется ли искривление или оно уже устойчиво.

Тракционная терапия

Устройство, мягко растягивающее половой член для уменьшения искривления и восстановления длины.

Коллагеназа (Xiaflex)

Инъекционный препарат, разрушающий бляшку.

Пликация / графтинг

Хирургические методы выпрямления полового члена.

НУЖНО ЛИ СРОЧНО ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ? Как правило, нет. В **активной фазе** искривление ещё меняется, поэтому основное внимание уделяется комфорту и нехирургическим методам. Операцию по выпрямлению предлагают после **стабилизации** — когда искривление перестало нарастать и боль прошла. Многие мужчины улучшаются без оперативного вмешательства.

Как это диагностируют

- Сбор анамнеза: характер искривления, боль, динамика изменений
- Осмотр с пальпацией бляшки; иногда фотофиксация эрекции или офисная оценка
- Иногда УЗИ для определения локализации бляшки и оценки кровотока

Как это лечат (по фазам)

- 1 Активная фаза** — наблюдение, обезболивание и часто **тракционная терапия**; цель — ограничить прогрессирование.
- 2 Инъекции в бляшку** — такие препараты, как **коллагеназа (Xiaflex)**, вводят непосредственно в бляшку для уменьшения искривления.
- 3 Операция (стабильная фаза)** — **пликация** (наложение швов на длинную сторону; наиболее простой метод, может укорачивать) или **иссечение бляшки с графтингом** (сохраняет длину; при выраженном искривлении).
- 4 Протез полового члена** — при сопутствующей эректильной дисфункции (ED). По каждому варианту есть отдельный листок.

Полезно знать

- Не пытайтесь принудительно «выпрямить» член — это может усилить травму.
- Если искривление не мешает половой жизни, может быть достаточно наблюдения.
- Болезнь Пейрони влияет на настроение и отношения — поддержка важна.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Искривление **мешает половому акту** или нарастает
- Выраженная **боль** при эрекции
- Новая **эректильная дисфункция** на фоне искривления

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

- 1.** Болезнь Пейрони — это рубцовая ткань, вызывающая искривление полового члена: частое, не раковое и поддающееся лечению состояние.
- 2.** Лечение зависит от фазы: комфорт и нехирургические методы в активной фазе; операция по выпрямлению — после стабилизации.
- 3.** Многие мужчины улучшаются без операции. Обратитесь к врачу при искривлении, мешающем половой жизни, стойкой боли или новой ED.